# Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)

*Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — VII*

**À RETENIR**

- Quelle que soit l'étiologie : hyperfixation des articulations atteintes, modérée, **très intense lors des poussées**, touchant les **deux versants** de l'articulation, pouvant s'étendre jusqu'à la métaphyse.
- SPA : **sacro-iliite symétrique** (quantification peu utilisée : rapport SI/sacrum, seuil **1,3**) + enthésopathies.
- PR : forme juvénile = temporo-maxillaire et manubrio-sternale ; forme adulte = mains, poignets, genoux.
- Mécanisme de l'hyperfixation articulaire : réaction ostéogénique + **↑ perméabilité synoviale** + protéines intra-articulaires liant le traceur.
- SAPHO : Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose, Ostéite ; atteinte **sterno-claviculaire** ; aspect en « **tête de taureau** » (*Bull's head*).

## 1. Généralités

Quelle que soit l'étiologie ⇒ hyperfixation des articulations concernées, parfois très intense au cours des poussées ; elle intéresse les **deux versants de l'articulation**, pouvant s'étendre jusqu'à la métaphyse.

## 2. Spondylarthrite ankylosante (SPA)

1. Atteinte **symétrique des sacro-iliaques** : quantification peu utilisée : rapport SI/sacrum < **1,3** **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement, un rapport SI/sacrum > 1,3 est en faveur d'une sacro-iliite (normal < 1,3)*.
2. Hyperfixation marquée des SI avec visualisation inhabituelle en antérieur.
3. La SO peut montrer en outre les autres atteintes d'arthrite ou d'**enthésopathie** (insertions ligamentaires ou tendineuses : genoux, chevilles, épaules « deltoïde »).

## 3. Polyarthrite rhumatoïde (PR)

1. Diagnostic clinique :
   - **forme juvénile** : atteinte temporo-maxillaire et manubrio-sternale ;
   - **forme adulte** : articulations des mains, poignets et genoux.
2. Dans l'arthrite, l'hyperfixation est due à (NB !) :
   1. la réaction ostéogénique des os adjacents ;
   2. l'↑ de la perméabilité synoviale, qui entraîne une diffusion du RT à travers la membrane synoviale ;
   3. la présence dans l'articulation d'un grand nombre de protéines auxquelles le RT est lié.
3. La SO est intéressante au stade de début, surtout si la clinique est atypique.
4. Hyperfixation intéressant les 02 versants de l'articulation, pouvant s'étendre à la métaphyse.

## 4. SAPHO

- Étiologie inconnue : **S**ynovite, **A**cné, **P**ustulose, **H**yperostose, **O**stéite.

1. Touche préférentiellement l'**articulation sterno-claviculaire**, avec élargissement d'une ou des clavicules dont l'architecture est remaniée.
2. Atteinte manubrio-sternale, acromio-claviculaire.
3. Atteinte de l'extrémité antérieure des côtes (thorax antérieur).

↳ Ce tableau est typiquement associé à une acné sévère + pustulose palmo-plantaire.

### La SO dans le SAPHO

1. Atteinte du thorax antérieur : aspect de « **tête de taureau** » ou « *Bull's head* ».
2. Tous les foyers correspondent à des foyers d'ostéite aseptique (« enthésite ossifiante »).
3. Utilité dans le bilan des atteintes et l'appréciation de l'évolutivité.

## 5. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Pathologies inflammatoires : hyperfixation modérée avec ↑ lors des poussées ; touche les 2 versants de l'articulation → jusqu'à la métaphyse.
- ① SPA : sacro-iliite → quantification SI/sacrum ; enthésopathies.
- ② PR : ↑ perméabilité synoviale + réaction ostéogénique + ↑ protéines dans l'espace articulaire → ↑ fixation.
- ③ SAPHO : *Bull's head* ⇒ ostéite + synovite + acné + pustulose + hyperostose.

---

### Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Caractéristique commune des hyperfixations inflammatoires articulaires ? | Atteinte des deux versants de l'articulation, pouvant s'étendre à la métaphyse ; ↑ lors des poussées. |
| **2.** Aspect scintigraphique de la SPA ? | Sacro-iliite symétrique marquée (visible en antérieur) ± enthésopathies. |
| **3.** Topographie de la PR juvénile vs adulte ? | Juvénile : temporo-maxillaire et manubrio-sternale ; adulte : mains, poignets, genoux. |
| **4.** Trois mécanismes de l'hyperfixation dans l'arthrite ? | Réaction ostéogénique, ↑ perméabilité synoviale, protéines intra-articulaires liant le RT. |
| **5.** Que signifie SAPHO ? | Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose, Ostéite. |
| **6.** Aspect scintigraphique typique du SAPHO ? | « Tête de taureau » (Bull's head) au thorax antérieur (sterno-claviculaires, manubrium). |